



BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO - MEDIC CẦN THƠ

TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG BẠCH CẦU CẤP Ở TRẺ EM

BS ĐỖ THỊ DIỄM PHƯƠNG



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

➤ Bệnh nhi nữ, 14 tuổi, địa chỉ: Kế Sách-Sóc Trăng, khám 15/01/2025

➤ Lý do đi khám: Sưng đau hạch vùng hàm (P)

Cách ngày khám khoảng 1 tháng, BN thấy sưng đau hạch vùng cổ, có sốt, khám ở bv ung bướu địa phương cấp toa 1 tuần bệnh không giảm. 1 tuần nay bệnh nhi chóng mặt, mệt mỏi, hạch cứng hơn, đau, có chảy máu mũi đến khám



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

PHIẾU SIÊU ÂM

Họ và tên bệnh nhân: [REDACTED]
Địa chỉ: Xã Trinh Phú,
Khoa: KHOA KHÁM BỆNH
Chẩn đoán: Viêm hạch bạch huyết cấp ở mặt, đầu và cổ; Đa hạch cổ 2 bên
Yêu cầu kiểm tra: Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ

KẾT QUẢ: SIÊU ÂM

Tuyến giáp: không to, bờ đều, cấu trúc chủ mô đồng nhất, không tăng sinh mạch máu, không bướu, không nang.
Tuyến dưới hàm 2 bên: không to, cấu trúc chủ mô đồng nhất, không bướu, không nang.
Tuyến mang tai 2 bên: không to, cấu trúc chủ mô đồng nhất, không bướu, không nang.
Dưới cằm + dưới hàm (P): có vài khối dẹp echo kém trung tâm echo dày D #10-23 (mm), giới hạn rõ, không tăng sinh mạch máu, còn cấu trúc rốn hạch.
Cổ 2 bên + sau tai (T): có vài khối dẹp echo kém trung tâm echo dày D #5-7 (mm), giới hạn rõ, không tăng sinh mạch máu.
Vùng vai (T): có 1 cấu trúc echo kém D#11x9 (mm), giới hạn rõ, bờ đều, không tăng sinh mạch máu.

KẾT LUẬN:
HẠCH VÙNG DƯỚI CẨM + DƯỚI HÀM (P)
HẠCH CỔ 2 BÊN + SAU TAI (T) DẠNG HẠCH VIÊM
U SƠI THẦN KINH VÙNG VAI (T)

Lời dẫn của BS chuyên khoa:

Ngày 06 tháng 01 năm 2025
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

PHIẾU NỘI SOI

MS: 25/BV-01
SỐ: 2501001976

Tuổi: 14
Số BHYT: [REDACTED]
Giới tính: Nữ
Buồng: 005
Giường: [REDACTED]

Chẩn đoán: Viêm hạch bạch huyết cấp ở mặt, đầu và cổ; Đa hạch cổ 2 bên
Yêu cầu kiểm tra: Nội soi tại mũi họng
Bác sĩ điều trị: [REDACTED]

KẾT QUẢ: NỘI SOI

- Tai (P): không u, màng nhĩ còn
- Tai (T): không u, màng nhĩ còn
- Hốc mũi (P): không u
- Hốc mũi (T): không u
- Vòm: VÙNG NIÊM MẠC VÒM LỆCH (T) CÓ VÀI CHẤM XUẤT HUYẾT
- Amidal (P) không to, không u
- Amidal (T) không to, không u
- Hạ họng: không u
- Xoang lê (T): không u
- Xoang lê (P): không u
- Thanh quản không u
- Dây thanh (P): trơn láng, không u, khớp mở tốt
- Dây thanh (T): trơn láng, không u, khớp mở tốt
- Ghi nhận khác:

KẾT LUẬN:
THEO DÕI VIÊM VÒM

Lời dẫn của BS chuyên khoa:
ĐỀ NGHỊ: ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA TÁI KHÁM SƠI TMH KIỂM TRA LẠI

Ngày 06 tháng 01 năm 2025
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

Điện thoại : 02923817901

ĐƠN THUỐC

Số HD: DR0.0012720201

Họ tên bệnh nhân: [REDACTED]

Tuổi: 14 Tuổi Giới tính: Nữ

Địa chỉ: Xã Trinh [REDACTED]

Số thẻ BHYT:

Chẩn đoán: Viêm hạch bạch huyết cấp ở mặt, đầu và cổ; Đa hạch cổ
Mã bệnh: L04.0
2 bên/ THEO DÕI viêm vòm

CHỈ ĐỊNH DÙNG THUỐC

1	Zelfamox 875/125 DT	14	viên
	<i>1viên/ lần *2 lần/ ngày 8-16h</i>		
2	Lornoxicam (Lornomeyer 4)	14	viên
	<i>1viên/ lần *2 lần/ ngày 8-16h</i>		
3	Cidetuss	14	viên
	<i>1viên/ lần *2 lần/ ngày 8-16h</i>		

Cộng khoản: 3

Lời dặn: -Toa: 7 ngày. 13/01/2025

Ngày 06 tháng 01 năm 2025

Bác sĩ khám bệnh

ĐÃ THU TIỀN



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

➤ Tình trạng lúc khám:

- Bệnh nhi tỉnh, mệt mỏi, da xanh, niêm nhợt, không xuất huyết dưới da
- M 100 l/p, HA 100/60mmHg
- Hạch dưới hàm P to, cứng, đau
- Tim đều, phổi không ran, bụng mềm gan lách to



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Họ tên người bệnh: [Redacted] Mã số bệnh phẩm: 10175603 Năm sinh: 2011 Nam/Hà: 140
Địa chỉ: [Redacted] Số thẻ BHYT: AK2949421663971
BS Chỉ định: BS. CKI. Đỗ Thị Diễm Phương
Khoa/Phòng: Khoa khám bệnh
Chẩn đoán: 188- Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu; R04.0- Chảy máu cam; R10.1- Đau bụng khu trú bụng trên
Thời gian lấy mẫu: 07:08 16/01/2025 Người lấy mẫu: CNXN. Đoàn Thị Như Ý
Thời gian nhận mẫu: 07:18 16/01/2025 Người nhận mẫu: CNXN. Nguyễn Phương Linh
Loại mẫu: Máu

Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Quy trình XN/ Thiết bị
Huyết đồ				
Số lượng hồng cầu	4.10	3.9 - 5.4	10 ¹² /L	K47-QTKT-HH-021/ DxH 900
Huyết sắc tố	108	125 - 145	g/L	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
Hematocrit	0.330	0.35 - 0.47	L/L	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
MCV	80.8	83 - 91	fL	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
MCH	26.3	27 - 31	pg	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
MCHC	325	320 - 351	g/L	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
RDW	14.6	12.0 - 15.0	%	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
Số lượng bạch cầu	172(±)	4.0 - 10.0	10 ⁹ /L	K47-QTKT-HH-022/ DxH 900
NEU	6.94	1.30 - 7.17	10 ⁹ /L	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
EOS	0.064	0.03 - 0.69	10 ⁹ /L	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
BASO	0.451	0.0 - 0.17	10 ⁹ /L	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
MONO	6.21	0.18 - 1.27	10 ⁹ /L	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
LYM	159	0.72 - 4.83	10 ⁹ /L	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
NEU%	4.03	32.7 - 71.7	%	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
EOS%	0.040	0.6 - 6.9	%	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
BASO%	0.260	0.0 - 1.7	%	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
LYM%	92.1	18.0 - 48.3	%	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
MONO%	3.60	4.4 - 12.7	%	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
Số lượng tiểu cầu	7.00 (***) (±)	150 - 400	10 ⁹ /L	K47-QTKT-HH-023/ DxH 900
PDW	16.1	9.0 - 17.0	fL	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900
MPV	11.5	7.3 - 11.1	fL	K47-QTKT-HH-020/ DxH 900

09 giờ 59, ngày 16 tháng 01 năm 2025
KHOA XÉT NGHIỆM

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Họ tên người bệnh: [Redacted] Mã số bệnh phẩm: 10175603 Năm sinh: 2011 Nam/Hà: 140
Địa chỉ: [Redacted] Số thẻ BHYT: AK2949421663971
BS Chỉ định: BS. CKI. Đỗ Thị Diễm Phương
Khoa/Phòng: Khoa khám bệnh
Chẩn đoán: 188- Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu; R04.0- Chảy máu cam; R10.1- Đau bụng khu trú bụng trên
Thời gian lấy mẫu: 07:08 16/01/2025 Người lấy mẫu: CNXN. Đoàn Thị Như Ý
Thời gian nhận mẫu: 07:18 16/01/2025 Người nhận mẫu: CNXN. Nguyễn Phương Linh
Loại mẫu: Máu

Tên xét nghiệm	Kết quả	Quy trình XN
Phết máu ngoại vi	Dòng hồng cầu: trái tương đối đều trên lame, hồng cầu đồng sắc, kích thước bình thường, hình dạng bình thường; Dòng bạch cầu: số lượng tăng cao, tìm thấy tế bào Blast, Promyelocyte; Dòng tiểu cầu: số lượng giảm rất thấp	K47-QTKT-HH-005

09 giờ 59, ngày 16 tháng 01 năm 2025
KHOA XÉT NGHIỆM



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Họ tên người bệnh: [Redacted] Năm sinh: 2011 Nam/Nữ: Nữ
Mã số bệnh phẩm: 10175603 Mã hồ sơ: 2500012018 Số thẻ BHYT: AK2949421663971
Địa chỉ: [Redacted] STT: [Redacted]
Khoa/Phòng: Khoa Khám bệnh BS Chỉ định: BS. CKI. Đỗ Thị Diễm Phương
Chẩn đoán: 188- Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu; R04.0- Chảy máu cam; R10.1- Đau bụng khu trú bụng trên
Thời gian lấy mẫu: 07:08 16/01/2025 Người lấy mẫu: CNXN. Đoàn Thị Như Ý
Thời gian nhận mẫu: 07:18 16/01/2025 Người nhận mẫu: CNXN. Nguyễn Phương Linh
Loại mẫu: Máu Tình trạng mẫu: Đạt

Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Quy trình XN/ Thiết bị
MIỄN DỊCH				
HBsAg miễn dịch tự động (A)	0.218	< 0.9 Negative Greyzone: 0.9 - 1.0 ≥ 1.0 Positive	COI	K47-QTKT-MD-060/ G1200
HBsAb định lượng (A)	1.50	< 10 Negative ≥ 10 Positive	IU/L	K47-QTKT-MD-062/ G1200
Anti HCV miễn dịch tự động (A)	0.104	< 0.9 Negative Greyzone: 0.9 - 1.0 ≥ 1.0 Positive	COI	K47-QTKT-MD-061/ G1200

09 giờ 59, ngày 16 tháng 01 năm 2025
KHOA XÉT NGHIỆM

phẩm đã được công nhận ISO 15189: 2022

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

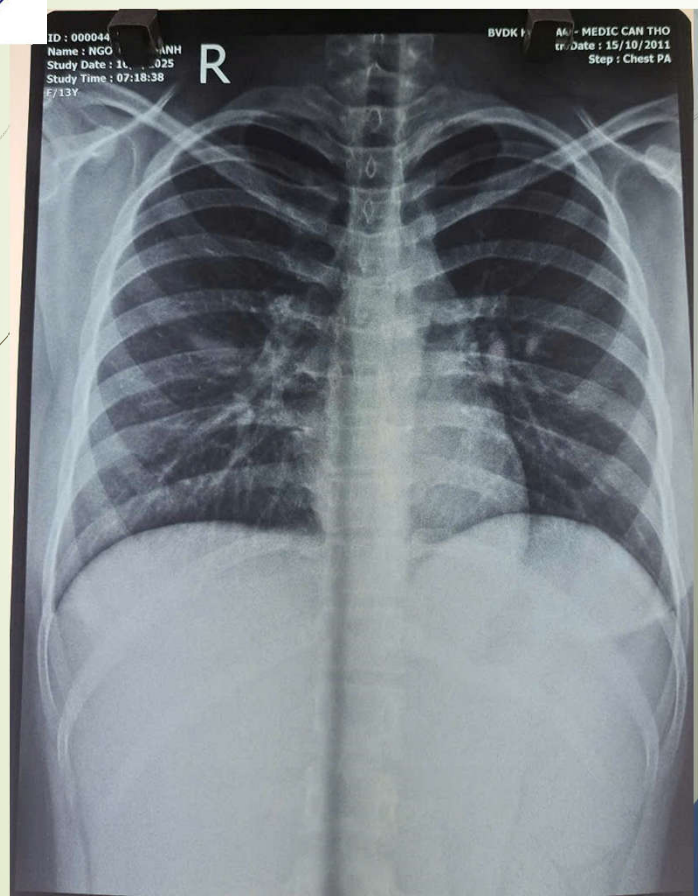
Họ tên người bệnh: [Redacted] Năm sinh: 2011 Nam/Nữ: Nữ
Mã số bệnh phẩm: 2500012018 Số thẻ BHYT: AK2949421663971
Địa chỉ: [Redacted] STT: 0786880340
Khoa/Phòng: Khoa khám bệnh BS Chỉ định: BS. CKI. Đỗ Thị Diễm Phương
Chẩn đoán: 188- Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu; R04.0- Chảy máu cam; R10.1- Đau bụng khu trú bụng trên
Thời gian lấy mẫu: 07:08 16/01/2025 Người lấy mẫu: CNXN. Đoàn Thị Như Ý
Thời gian nhận mẫu: 07:18 16/01/2025 Người nhận mẫu: CNXN. Nguyễn Phương Linh
Loại mẫu: Máu Tình trạng mẫu: Đạt

Tên xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Quy trình XN/ Thiết bị
HÓA SINH MÀU				
Glucose (C)	5.42	3.3 - 5.6	mmol/L	K47-QTKT-SH-092/ Cobas c503-1
Creatinin (C)	62.5	15-77	μmol/L	K47-QTKT-SH-094/ Cobas c503-1
Độ lọc cầu thận ước tính - eGFR (CKD-EPI 2021)	130.15	> 90	mL/phút/1.73m ²	
AST (GOT) (A)	32.4	< 31	U/L	K47-QTKT-SH-095/ Cobas c503-1
ALT (GPT) (A)	34.6	< 31	U/L	K47-QTKT-SH-096/ Cobas c503-1
GGT (C)	38.7	< 36	U/L	K47-QTKT-SH-097/ Cobas c503-1

09 giờ 59, ngày 16 tháng 01 năm 2025
KHOA XÉT NGHIỆM



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG



PHIEU NỘI SOI

Họ tên người bệnh: [Redacted] Tuổi: 14 tuổi Nam/Nữ: Nữ
Địa chỉ: Ấp 1, Xã T [Redacted]
Số BHYT: AK 2 94 94 21663971
Khoa: Khoa Khám bệnh Buồng: PK22 - Nhi Giường: [Redacted]
Chẩn đoán: 188-Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu; R04.0-Chảy máu cam; R10.1-Đau bụng khu trú bụng trên
Yêu cầu kiểm tra: Nội soi mũi
Bác sỹ điều trị: BS. CKI. Đỗ Thị Diễm Phương

HÌNH ẢNH NỘI SOI

Số đối vị trí các xoang ở người trưởng thành

KẾT QUẢ NỘI SOI

TRÁI	CẤU TRÚC	PHẢI
THẮNG	VÁCH NGĂN	THẮNG
PHỦ NẾ	NIÊM MẠC MŨI	PHỦ NẾ
BÌNH THƯỜNG	CUỐN MŨI GIỮA	SUNG HUYẾT
BÌNH THƯỜNG	CUỐN MŨI DƯỚI	BÌNH THƯỜNG
THOÁNG	KHE MŨI GIỮA	THOÁNG
THOÁNG	KHE MŨI TRÊN	THOÁNG
BÌNH THƯỜNG	MÔM MÓC, BÓNG SÁNG	BÌNH THƯỜNG
NHẢY + SUNG HUYẾT	VÒM	NHẢY + SUNG HUYẾT
	KHÁC	

KẾT LUẬN:

VIÊM SUNG HUYẾT LYMPHO VÒM

Ngày 16 tháng 01 năm 2025
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

TRUNG TÂM Y TẾ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA - MEDIC CẦN THƠ

MS: 22/BV-01
Số: 2500012018

PHIẾU SIÊU ÂM

Họ tên người bệnh: [Redacted]
Địa chỉ: Ấp 1, Xã [Redacted]
Số BHYT: AK 2.94.94.21663971
Khoa: Khoa Khám bệnh
Chẩn đoán: 188-Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu; R04.0-Chảy máu cam; R10.1-Đau bụng khu trú bụng trên
Yêu cầu kiểm tra: Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)
Bác sĩ điều trị: BS. CKI. Đỗ Thị Diễm Phương

Tuổi: 14 tuổi Nam/Nữ: Nữ

Buồng: PK22 - Nhi
Giường:

KẾT QUẢ SIÊU ÂM

- GAN: Gan trái KT # 130 mm, gan phải KT # 184 mm, bờ đều, cấu trúc đồng dạng, không sang thương khu trú.
- MẬT:
 - + Túi mật: Không to, thành không dày, không sỏi.
 - + Đường mật: Đường mật trong gan. Không giãn, không sỏi.
- TUY: Không to, cấu trúc đồng nhất
- LÁCH: to KT # 177 mm, cấu trúc đồng nhất
- THẬN TRÁI: Không sỏi, không ứ nước, chủ mô phân biệt rõ.
- THẬN PHẢI: Không sỏi, không ứ nước, chủ mô phân biệt rõ.
- BÀNG QUANG: Thành không dày, không sỏi
- TỬ CUNG: Ngã trước, DAP # 27 mm, nội mạc # 6 mm, cấu trúc đồng dạng. Ít dịch tử cung.
- PHÂN PHỤ: Cạnh phải tử cung có 1 cấu trúc echo kém KT # 52 x 46 mm, bờ đều, giới hạn rõ, không tăng sinh mạch.
- ĐM CHỦ BỤNG: Không phình.
- Ổ BỤNG: Không dịch, không hạch, Cocard Sign (-)
- CÁC CƠ QUAN KHÁC: Không dịch màng phổi hai bên

KẾT LUẬN
GAN TO.
LÁCH TO.
ÍT DỊCH TỬ CUNG.
THEO DÕI U BƯỚNG TRỨNG PHẢI.
Đề nghị: Kết hợp thêm lâm sàng và cận lâm sàng khác

Ngày 16 tháng 01 năm 2025
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

TRUNG TÂM Y TẾ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA - MEDIC CẦN THƠ

MS: 22/BV-01
Số: 2500012018

PHIẾU SIÊU ÂM

Họ tên người bệnh: [Redacted]
Địa chỉ: Ấp 1, Xã [Redacted]
Số BHYT: AK 2.94.94.21663971
Khoa: Khoa Khám bệnh
Chẩn đoán: 188-Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu; R04.0-Chảy máu cam; R10.1-Đau bụng khu trú bụng trên
Yêu cầu kiểm tra: Siêu âm hạch vùng cổ
Bác sĩ điều trị: BS. CKI. Đỗ Thị Diễm Phương

Tuổi: 14 tuổi Nam/Nữ: Nữ

Buồng: PK22 - Nhi
Giường:

KẾT QUẢ SIÊU ÂM

- Tuyến mang tai: Tuyến mang tai hai bên có cấu trúc kém đồng dạng, tăng sinh mạch.
- Tuyến dưới hàm, tuyến dưới lưỡi: Không to, chủ mô đồng dạng, không u, không viêm.
- Hạch cổ: Vùng cổ có nhiều cấu trúc echo kém hình bầu dục KT lớn nhất # 26 x 13 mm, cấu trúc rỗng hạch (+/-).

KẾT LUẬN
VIÊM TUYẾN MANG TAI HAI BÊN.
HẠCH VÙNG CỎ, HẠCH CHƯA RÕ BẢN CHẤT.
ĐỀ NGHỊ: KẾT HỢP KHÁM CHUYÊN KHOA HẠCH LỚN DƯỚI HẸM TRÁI

Ngày 16 tháng 01 năm 2025
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

BTH BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
KHOA GPB
Số 1 Trần Hữu Nghiệp, Xã Tân Kiên, Huyện
Bình Chánh - TP.HCM
Điện thoại: (028) 38397535 - 128

Mã y tế: 25900093
Số lưu trữ: 4348
Đối tượng:

Mã số quy trình: QT-GPB-08/BMG-1
IAC-MRA

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM TẾ BÀO HỌC TỤY XƯƠNG (TỤY ĐỎ)

THÔNG TIN BỆNH NHÂN			THÔNG TIN MẪU		
Họ và tên: N			Nơi gửi: KHOA HUYẾT HỌC TRẺ EM 1		
Năm sinh: 15/10/2011			BS chỉ định: BS. Nguyễn Thân Ngọc Quyên		
Giới tính: Nữ			Ngày giờ lấy mẫu: 17/01/2025 15:20		
Địa chỉ:			Ngày giờ nhận mẫu: 17/01/2025 16:30		
Trắng			Loại mẫu: Tủy hút		
Chẩn đoán: BỆNH BẠCH CẦU KHÔNG XÁC ĐỊNH;			Chất lượng mẫu: Đạt		

TỶ LỆ PHẦN TRĂM CỦA CÁC DÒNG TẾ BÀO TỤY XƯƠNG					
Dòng tế bào	Tỷ lệ khảo sát (%)	Khoảng bình thường (%)	Dòng tế bào	Tỷ lệ khảo sát (%)	Khoảng bình thường (%)
Myeloblast		0.2 - 1.5	Erythroid series		18.4 - 33.8
Promyelocyte		2.1 - 4.1	Proerythroblast		0.2 - 1.3
Neutrophil		49.2 - 65.0	Basophilic Erythroblast		0.5 - 2.4
Myelocyte		8.2 - 15.7	Polychromatophilic E.		17.9 - 29.2
Metamyelocyte		9.6 - 15.3	Acidophilic Erythroblast		0.4 - 4.6
Band and Segment		15.5 - 27.3	Monocytes series		0 - 0.8
Eosinophil series		1.2 - 5.3	Lymphocytes series		11.1 - 23.2
Metamyelocyte		0.2 - 1.3	Plasma cell		0.4 - 3.9
Myelocyte		0.4 - 2.2	Histiocyte		0.0 - 0.5
Band and Segment		0.2 - 3.7	Megakaryocyte		Hiện diện
Basophil series		0.0 - 0.2	Other cells:.....		0.0 - 0.0

MÔ TẢ TIÊU BẢN TỤY HÚT VÀ MÁU NGOẠI BIÊN

Hạt tủy giàu. Mật độ tế bào tăng. Giảm sinh 3 dòng tế bào tủy bình thường. Tăng tỷ lệ tế bào non khoảng 90% mật độ tế bào tủy, kích thước 10-12 micrometres, nhân tròn, oval, nhiễm sắc chất mịn, tỷ lệ N/C khoảng 5/1, nguyên sinh chất kiềm trung bình, không chứa hạt, peroxidase âm tính.

Lam máu: Hồng cầu aniso-poikilocytosis (+). Bạch cầu S.neutrophil giảm, hiện diện nhiều tế bào non.

Tiểu cầu giảm.

PHƯƠNG PHÁP NHUỘM

Phương pháp	Giemsa (QT-GPB-08)	Wright Giemsa (QT-GPB-08)	Peroxidase (QT-GPB-08)	Khác:.....
Nhuộm				



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

BTH  Sở Y Tế Tp Hồ Chí Minh
BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA HUYẾT HỌC TRẺ EM I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MS: 01/BV-01
Số lưu trữ: 0050158/25
Số BA: 25.006473
Mã y tế: 25900093

GIẤY RA VIỆN

Họ tên người bệnh: [REDACTED]
Ngày/tháng/năm sinh: 15/10/2011 (14 tuổi) Nam/Nữ: Nữ
Dân tộc: Kinh Nghề nghiệp: Sinh viên, học sinh
Số CCCD/CMND/Định danh công dân/Hộ chiếu: [REDACTED] Ngày cấp: 18/09/2024
Mã số BHXH/Thẻ BHYT số: AK2949421663971
Địa chỉ: [REDACTED]
Vào viện lúc: 20 giờ 34 phút Ngày 28 tháng 07 năm 2025
Ra viện lúc: 09 giờ 00 phút Ngày 21 tháng 08 năm 2025
Chẩn đoán: Bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ALL) (C91.0); Chảy máu bất thường khác của tử cung và âm đạo (N93); Nhiễm trùng huyết do vi trùng gram âm khác (A41.5)
Phương pháp điều trị: Phác đồ giảm cường độ Corticoid và Vincristin, kháng sinh tĩnh mạch, truyền chế phẩm máu
Ghi chú: Tái khám phòng khám HHTE1 vào ngày 28/08/2025
Ngày 21 tháng 08 năm 2025
Đại diện đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

BTH BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
KHOA GIẢI PHẪU BỆNH
Số 1 Trần Hữu Nghiệp, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38397535 - 128

Mã y tế: 25900093 Mã số quy trình: QT-GPB-08/BM01
Số hồ sơ: 8875
Đối tượng: —

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM TẾ BÀO HỌC TỦY XƯƠNG (TỦY ĐỎ)

THÔNG TIN BỆNH NHÂN			THÔNG TIN MẪU		
Họ và tên: [REDACTED]			Nơi gửi: PHÒNG KHÁM 11		
Năm sinh: 15/10/2011			BS chỉ định: BS Hồ Châu Minh Thư		
Giới tính: Nữ			Ngày giờ lấy mẫu: 04/09/2025 13:35		
Mã bệnh: [REDACTED]			Ngày giờ nhận mẫu: 04/09/2025 14:40		
Trang: [REDACTED]			Loại mẫu: Tủy hút		
Chẩn đoán: BỆNH BẠCH CẦU DẠNG NGUYÊN BẢO LYMPHO CẤP (ALL)(C91.0)			Chất lượng mẫu: Đạt		

TỶ LỆ PHẦN TRĂM CỦA CÁC DÒNG TẾ BÀO TỦY XƯƠNG					
Dòng tế bào	Tỷ lệ khảo sát (%)	Khoảng bình thường (%)	Dòng tế bào	Tỷ lệ khảo sát (%)	Khoảng bình thường (%)
Myeloblast	—	0.2 - 1.5	Erythroid series	50	18.4 - 33.8
Promyelocyte	—	2.1 - 4.1	Proerythroblast	—	0.2 - 1.3
Neutrophil	35	49.2 - 65.0	Basophilic Erythroblast	—	0.5 - 2.4
Myelocyte	—	8.2 - 15.7	Polyehromatophilic E.	—	17.9 - 29.2
Metamyelocyte	—	9.6 - 15.3	Acidophilic Erythroblast	—	0.4 - 4.6
Band and Segment	—	15.5 - 27.3	Monocytes series	—	0 - 0.8
Eosinophil series	2	1.2 - 5.3	Lymphocytes series	7	11.1 - 23.2
Metamyelocyte	—	0.2 - 1.3	Plasma cell	—	0.4 - 3.9
Myelocyte	—	0.4 - 2.2	Histiocyte	—	0.0 - 0.5
Band and Segment	—	0.2 - 3.7	Megakaryocyte	—	Hiện diện
Basophil series	—	0.0 - 0.2	Other cells:.....	blast 6	0.0 - 0.0

MÔ TẢ TIÊU BẢN TỦY HÚT VÀ MÁU NGOẠI BIÊN

Hạt tủy trung bình. Mật độ tế bào bình thường. Mẫu tiêu bản khoảng 20 tế bào trên lam, đầy đủ giai đoạn. Đồng hồng cầu chủ yếu E.polychromatophilic-acidophil. Đồng bạch cầu hạt: ưu thế Myelocyte-Metamyelocyte. Tỷ lệ blast khoảng 6%.

Lam máu: Hồng cầu anisocytosis poikilocytosis (+), vài hồng cầu nhân. Bạch cầu hiện diện: S.Neutrophil. Tiêu bản tập trung bình thường.

PHƯƠNG PHÁP NHUỘM				
Phương pháp	Giemsa (QT-GPB-08)	Wright Giemsa (QT-GPB-08)	Peroxidase (QT-GPB-08)	Khác:
Nhuộm				

Trang 1 / 2



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

BTH BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
KHOA HUYẾT SINH HỌC
Số 1 Trần Hữu Nghiệp, xã Tân Nhựt, TP HCM
Tel: 028.38397535 - Ext. 141
ISO 9001:2015

Mã QT: QT-HSH-150/BM01
Mã y tế: 25900093
SID: **201125-199**
Đối tượng: BHYT 2 (100%)

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Bệnh phẩm: Máu

Họ tên: [Redacted]
Địa chỉ: [Redacted]
Chẩn đoán: Bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (all)(c91.0)
BS chỉ định: BS Hồ Châu Minh Thư
Ngày giờ lấy mẫu: 20/11/2025 10:38:15
Ngày giờ nhận mẫu: 20/11/2025 10:45:00

Ngày sinh: 15/10/2011 Giới: Nữ
Nơi gửi: PHÒNG KIỂM II
Chất lượng mẫu: Đạt
Ngày giờ kết quả: 20/11/2025 11:30:16

Yêu cầu xét nghiệm	Kết quả xét nghiệm	Khoảng tham chiếu	Đơn vị	Máy NN	Mã QTNN
Huyết Học					
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser:					
RBC*	4.35	(3.90 - 5.15)	M/ μ L	Advia2120i 2	QT-HSH-174
HGB *	12.7	(12.0 - 15.4)	g/dL		QT-HSH-176
HCT	38.7	(35.5 - 45)	%		
MCV	88.8	(78 - 93)	fL		
MCH	29.1	(26.0 - 32.5)	pg		
MCHC	32.8	(31.5 - 36.0)	g/dL		
CHCM	32.2	(33 - 37)	g/dL		
CH	28.6	(27 - 31)	pg		
RDW	17.5	(11.5 - 14.5)	%		
PLT	190	(170 - 400)	K/uL		QT-HSH-175
MPV	8.6	(7.4 - 10.9)	fL		
WBC	6.31	(4.5 - 11.4)	K/uL		QT-HSH-173
%NEUT	66.9	(36 - 77)	%		
%LYMPH	24.5	(20 - 47)	%		
%MONO	5.6	(1.5 - 8.5)	%		
%EOS	1.0	(0.5 - 5.5)	%		
%BASO	0.3	(0.0 - 1.75)	%		
%LUC	1.7	(0 - 4)	%		
#NEUT	4.22	(1.7 - 7.9)	K/uL		
#LYMPH	1.54	(1.2 - 5.0)	K/uL		
#MONO	0.35	(0.10 - 0.95)	K/uL		
#EOS	0.06	(0.02 - 0.65)	K/uL		
#BASO	0.02	(0.0 - 0.2)	K/uL		
#LUC	0.11	(0 - 0.4)	K/uL		



BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM

- Bệnh chiếm tỷ lệ khoảng 75% bệnh máu ác tính và khoảng 25-30% ung thư ở trẻ em
- Thường gặp ở nhóm 2-5 tuổi
- Chẩn đoán sớm, xếp loại nguy cơ theo đặc điểm tế bào – SHPT và hóa trị, chăm sóc hồi sức huyết học giúp bệnh có khả năng được chữa khỏi



BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM

CHẨN ĐOÁN

LÂM SÀNG

- Toàn thân: Mệt mỏi, chán ăn, sụt cân; Sốt; HC Thiếu máu; HC Xuất huyết; HC nhiễm trùng
- TC thâm nhiễm: Hạch to, gan lách to, đau xương, TK (đau đầu, nôn, liệt thần kinh sọ,...)



BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM

CẬN LÂM SÀNG

- Huyết đồ: BC số lượng thường tăng, có thể có bạch cầu non ra máu ngoại vi (nguyên bào lympho); Hb thường giảm, mức độ từ nhẹ đến nặng; TC thường giảm hoặc có thể bình thường
- Tủy đồ: tỷ lệ tế bào non ác tính $\geq 20\%$
- Miễn dịch tế bào
 - + Dấu ấn tế bào non: CD34 (+), HLA-DR (+), TdT (+)
 - + Dòng lympho B (85%)
 - + Dòng Lympho T (15%)



BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM

CẬN LÂM SÀNG

➡ Di truyền tế bào và SHPT

+ Bất thường về NST

- Giảm bội (hypodiploid) $< 46\text{NST}$;
- 46 NST với cấu trúc bất thường (pseudodiploid);
- Trên lưỡng bội 47-50 NST (hyperdiploid);
- > 50 NST (hyper-hyperdiploid)



BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM

CẬN LÂM SÀNG

➤ Di truyền tế bào và SHPT

+ Các đột biến gen:

- Gen kết hợp *TEL-AML1* tạo bởi chuyển đoạn t(12;21) (p13q22). t(12;21), 22% của Pre-B ALL;
- Gen kết hợp *BCR-ABL* tạo bởi chuyển đoạn t(9;22) (q34q11). t(9;22), 3% ALL trẻ em;
- Tái sắp xếp gen *MLL* tại vị trí 11q23 ảnh hưởng 80% của trẻ nữ nhi, 3% của ALL trẻ lớn;
- Các chuyển đoạn gen của lơ xê mi lympho B cấp liên quan gen *MYC* trên NST 8q24. 80% B-ALL có t(8;14) (q24;q32);
- > 50% trường hợp Lơ xê mi lympho T cấp có đột biến hoạt động liên quan đến gen *NOTCH1*.



BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM

CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH

- Tiêu chuẩn lâm sàng
- Hình thái học, nhuộm hoá học tế bào
- Phân loại miễn dịch và các biến đổi di truyền đặc trưng của dòng lympho.
- Chẩn đoán xác định khi nguyên bào lympho chiếm trên 20% tế bào có nhân trong tủy, mang dấu ấn miễn dịch đặc trưng dòng lympho



BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM

CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG VÀ NHÓM NGUY CƠ

Nguy cơ thường: trẻ từ 1-10 tuổi và số lượng bạch cầu ngoại biên lúc chẩn đoán $< 50\text{G/L}$

Nguy cơ cao: trẻ < 1 tuổi và ≥ 10 tuổi hoặc số lượng bạch cầu ngoại biên lúc chẩn đoán $> 50\text{G/L}$



BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM

ĐIỀU TRỊ

- Thường sử dụng các phác đồ đa hoá trị liệu như: **FRALLE 2000**, NOPHO, BFM, UK, CCG 1961, CCG1991, COG, COALL, Study VII... trong phác đồ có các thuốc, hoá chất như prednison, dexamethasone, vincristine, methotrexate, anthracycline, cytarabine, L-asparaginase, cyclophosphamide, mercaptopurine,..., kết hợp tiêm tuỷ sống và xạ trị



BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM

Điều trị BCC lympho cấp theo FRALLE

- + Giai đoạn cảm ứng;
- + Điều trị tấn công;
- + Điều trị củng cố;
- + Điều trị tăng cường 1;
- + Điều trị trung gian;
- + Điều trị tăng cường 2;
- + Điều trị duy trì.



BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM

Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ đáp ứng đối với điều trị đặc hiệu theo NCCN 2016:

➤ **Tiêu chuẩn đánh giá lui bệnh**

- Tiêu chuẩn lui bệnh hoàn toàn về mặt huyết học (CR):

+ **Không phát hiện tế bào ác tính** trong máu ngoại vi hay biểu hiện thâm nhiễm ngoài tủy

+ **Tỷ lệ blast < 5%** tổng số tế bào có nhân trong tủy;

+ **BC > 1 G/l;**

+ **TC > 100 G/l;**

+ **Không tái phát trong vòng 4 tuần.**

- Lui bệnh không hoàn toàn về mặt huyết học (CRi): Có đầy đủ tiêu chuẩn lui bệnh hoàn toàn ngoại trừ:

+ Số lượng bạch cầu hạt máu ngoại vi < 1 G/l;

+ Số lượng tiểu cầu < 100 G/l;

- Không lui bệnh về mặt huyết học (NR): Không đạt được các tiêu chuẩn CR khi kết thúc điều trị cảm ứng.



BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM

Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ đáp ứng đối với điều trị đặc hiệu theo NCCN 2016:

➤ Tiêu chuẩn tái phát

- Tái phát tuỷ xương đơn độc: Sau khi đạt lui bệnh hoàn toàn, bệnh nhi có biểu hiện thiếu máu, xuất huyết dưới da, sốt, hạch to trở lại..., xuất hiện tế bào blast trong máu ngoại vi, **tuỷ xương có $\geq 25\%$ tế bào blast**.
- Tái phát tuỷ xương kết hợp: Tái phát tuỷ xương + có ít nhất 1 vị trí tái phát ngoài tuỷ xương.
- Tái phát TKTW: Có hoặc không có đau đầu, buồn nôn, **dịch não tuỷ có > 5 bạch cầu/mm³ và có tế bào blast**, hoặc có u nội sọ, tổn thương các dây thần kinh sọ, tổn thương võng mạc không giải thích được nguyên nhân.
- Tái phát ngoài tuỷ khác: Có hiện diện của nguyên bào lympho ở thận hay tinh hoàn..



BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM

➔ **Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ đáp ứng đối với điều trị đặc hiệu theo NCCN 2016:**

Điều trị tái phát

- Điều trị hóa chất phác đồ tái phát: Có thể lựa chọn một trong các phác đồ BFM- REZ 85, COPRALL 2005, FLAG, FLAG-Daunorubicin, FLAG-IDA, Mito-FLAG, **sau đó ghép tủy đồng loài**
- Tái phát thần kinh trung ương hay tái phát tinh hoàn đơn thuần: Sử dụng phác đồ O2P2 (Mỹ).



BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM

➤ Cập nhật hướng điều trị mới:

Điều trị nhắm đích kết hợp điều trị hóa đích bao gồm:

- Liệu pháp phân tử:

- + Ức chế tyrosine kinase ABL1 (imatinib) cho bệnh nhân Ph⁺ hoặc Ph-like B-ALL hoặc T-ALL với NUP-214- ABL1;
- + Ức chế JAK (ruxolitinib) cho Ph-like hoặc ETP hoặc JAK-dependent ALL;
- + Bortezomib cho B/T-ALL tái phát;
- + Ức chế Notch (LY3039478) cho T-ALL.

- Liệu pháp kháng thể miễn dịch: anti-CD19, anti-CD22.

- Liệu pháp tế bào: CD19 CAR T cells, CD22 CAR T cells.